

Основоположник андрологии в России: {

=Синицын И.Ф.

~Кирпатовский И.Д.

~Тиктинский О.Л.

~Петров П.П.

~Игнатьев И.М.

}

Задачи андрологии {

~репродуктивное здоровье мужчин

~мочевыделительная система у мужчин

~заболевания желез внутренней секреции

~заболевания желез внешней секреции

=все перечисленное верно.

}

Что не входит в основные направления в андрологии: {

~мужское бесплодие;

~детская андрология;

=гипертиреоз;

~сексуальные дисфункции;

~гипогонадизм

}

В каком году создана в России и зарегистрирована профессиональная ассоциация андрологов (ПААР) {

~1971

~1986

=1996

~2010

~1950

}

В каком году на базе клиники мочеполовых болезней медицинского факультета Московского университета была открыта первая андрологическая клиника: {

~1877

~1917

~1941

~1972

=1979

}

Специализированное учреждение МЗ РД, оказывающее медицинскую помощь мужчинам в бесплодном браке: {

~Республиканская клиническая больница

~Республиканский урологический центр

=Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции

~женские консультации

~поликлиники, по месту жительства пациентов

}

Первая беременность в Дагестане, после проведенного ЭКО: {

~2000 год

=2003 год

~2006 год

~2009 год

~2012 год

}

К наружным половым органам относятся: {

~яички и их придатки,

=мошонка

~семявыносящие и семявыбрасывающие протоки,
~бульбоуретральные железы,
~простата и семенные пузырьки

}

Длина мужской уретры {

~8-10 см
~10-15 см.
=20-25 см
~35-40 см
~40-50 см.

}

Самый узкий и короткий отдел мужской уретры: {

~простатическая часть
=перепончатая часть
~пещеристая часть
~привратниковая часть
~все отделы уретры одинаковы по размеру

}

Оптимальной температуры, необходимой для созревания сперматозоидов в яичках составляет: {

~менее 30градусовС
~31-33градусовС
=34-35 градусовС
~36-38градусовС
~38-40градусовС

}

Сколько долек располагается в каждом яичке: {

~2-3
~25-30
=250-300
~1000-5000
~более 1 млн.

}

В какой части сперматозоида находится акросома, которая содержит ферменты, необходимые для растворения оболочки яйцеклетки: {

=головка
~шейка
~тело
~хвост
~придаток

}

Сколько ацинусов в предстательной железе {

=30-50
~2-3
~10-15
~около 100
~несколько миллионов

}

Скорость движения сперматозоида человека может достигать: {

~1 см в час
~10 см. в час
=30 см. в час
~не более 1 см. в час.
~несколько метров в час

}

Гормон, непосредственно стимулирующий клетки Лейдига, для выработки тестостерона: {

~Тестостерон

=ЛГ

~ФСГ

~Пролактин

~АКТГ

}

Доля свободного от общего тестостерона: {

=около 2 %

~около 10 %

~около 25 %

~около 50 %

~более 95%

}

Гормон, непосредственно стимулирующий клетки Сертоли, для выработки сперматозоидов: {

~Тестостерон

~ЛГ

=ФСГ

~Пролактин

~ПСА

}

Длина семявыносящего протока: {

~10-20 см

~20-30см

=40-50 см

~50-70 см

~около 1 метра

}

Объем выделенной мочи в сутки называется: {

~энурез

~парез

=диурез

~никтурия

~странгурия

}

Семявыбрасывающий проток открывается в: {

~семенной пузырьёк

~ладьевидную ямку

~предстательную железу

=семенной бугорок

~наружное отверстие уретры.

}

Что не входит в семенной канатик: {

~семявыносящий проток

~артерии (яичковая и семявыносящего протока)

~венозное лозовидное сплетение

~нервы, лимфатические сосуды яичка и его придатка

=семенной бугорок

}

Специальный лабораторный анализ, который представляет собой микроскопию выделений, полученных из уретры. {

~ПЦР

=мазок на флору

~анализ секрета простаты
~спермограмма
~андрофлор

}

Высокоточный метод диагностики инфекций, который способен идентифицировать возбудителя на основе выявления их генетического материала {

~мазок на флору

=ПЦР

~ИФА

~культуральный метод

~бакпосев

}

Информативность метода ПЦР на ЗППП: {

~до 50%

~50-60%

~60-70 %

~80-90%

=95% и выше

}

Где вырабатываются гормоны ЛГ и ФСГ: {

=в передней доле гипофиза

~в задней доле гипофиза

~в гипоталамусе

~в надпочечниках

~в яичках

}

Как называется диагностический маркер заболеваний предстательной железы? {

~АЛТ

=ПСА

~РНК

~ТТГ

~АКТГ

}

Для проведения локализационного теста для простатита (Проба Meares и Stamey), необходимо пациенту собрать: {

~1 порцию мочи

~2 порции мочи

~3 порции мочи

=4 порции мочи

~5 порций мочи

}

Чувствительность и специфичность пробы Meares и Stamey для остановки диагноза простатит, составляет: {

~не более 20%

~20-50%

~50%

~60-80%

=более 90%

}

Для проведения локализационного теста для простатита (Проба Nickel), необходимо пациенту собрать: {

~1 порцию мочи

=2 порции мочи

~3 порции мочи

~4 порции мочи

~5 порций мочи

}

Метод исследования динамических характеристик потока мочи: {

~уретроскопия

~уретрография

=урофлоуметрия

~цистоскопия

~хромоцистография

}

Высокоинформативный метод диагностического осмотра слизистой мочеиспускательного канала и его просвета {

=уретроскопия

~уретрография

~урофлоуметрия

~цистоскопия

~хромоцистография

}

Назовите противопоказания для выполнения уретроскопии: {

~макрогематурия

~беременность

~множественные дивертикулы мочевого пузыря

=острые воспалительные заболевания нижних мочевых путей

~полиурия

}

Болезненное мочеиспускание в сочетании с его учащением – это: {

=странгурия

~энурез

~никтурия

~недержание мочи

~поллакиурия

}

Укажите общие нормы ПСА крови для всех возрастов: {

~от 5 до 10 нг/мл

~от 0 до 6 нг/мл

=от 0 до 4 нг/мл

~от 4 до 7 нг/мл

~от 10 до 20 нг/мл

}

Гормон, который в большей своей части у мужчин образуется в результате ароматизации андрогенов: {

~тестостерон

~лютеинизирующий гормон

~фолликулостимулирующий гормон

~ингибин В

=эстрадиол

}

Гормон в мужском организме, который является первичным регулятором секреции ФСГ: {

~тестостерон

~лютеинизирующий гормон

~пролактин

=ингибин В

~эстрадиол

}

Лабораторное исследование, которое позволяет определить качественные и количественные характеристики эякулята: {

- ~эякулят
- =спермограмма
- ~урограмма
- ~корпорограмма
- ~все верно

}

Нормальное количество сперматозоидов в 1 мл. по ВОЗ (2010): {

- =более 15 млн.
- ~более 20 млн.
- ~более 40 млн.
- ~более 60 млн
- ~более 100 млн.

}

Количество сперматозоидов с нормальной морфологией по Крюгеру. по ВОЗ (2010): {

- =не менее 3-4%;
- ~не менее 14%
- ~не менее 30%
- ~не менее 50%
- ~не менее 60%.

}

Оптимальные сроки полового воздержания перед сдачей спермограммы: {

- ~до 3 суток
- =от 3 до 6 суток
- ~от 7 до 10 суток.
- ~от 7, но не более 14 суток
- ~не имеет значения.

}

Параметр, который описывает их внешнее строение: размер, форму, соотношение частей сперматозоида: {

- ~МАР-тест;
- =морфология сперматозоидов;
- ~ДНК-фрагментация;
- ~тест на жизнеспособность
- ~НВА-тест

}

Снижение количества сперматозоидов называется: {

- =олигозооспермия
- ~астенозооспермия
- ~тератозооспермия
- ~пиоспермия
- ~азооспермия

}

Отсутствие сперматозоидов в эякуляте называется: {

- ~олигозооспермия
- ~астенозооспермия
- ~тератозооспермия
- ~пиоспермия
- =азооспермия

}

Единичные сперматозоиды в эякуляте называется: {

- =криптозооспермия
- ~астенозооспермия
- ~тератозооспермия

~пиоспермия
~азооспермия

}

Снижение подвижности сперматозоидов называется: {

~олигозооспермия
=астенозооспермия
~тератозооспермия
~пиоспермия.
~азооспермия

}

Снижение количества сперматозоидов с нормальной морфологией называется: {

~олигозооспермия
~астенозооспермия
=тератозооспермия
~пиоспермия
~азооспермия

}

Гемоспермия это: {

~примесь крови в моче
~наличие миоглобина в моче
=кровь в сперме
~выделение крови из мочеиспускательного канала
~повышения вязкости эякулята

}

Где происходит функциональная зрелость и приобретают подвижность сперматозоиды? {

~в семенных канальцах яичка
~в средостении яичка
=в придатках яичка
~в ампуле семявыносящего протока
~в цервикальном канале женщины

}

Вещество, вырабатываемые в семенных пузырьках: {

~цинк
=фруктоза
~щелочная и кислая фосфатазы
~спермидин и спермин
~альфа-глюкозидаза

}

Вещество, вырабатываемое в предстательной железе: {

=цинк
~фруктоза
~простогландины
~L-карнитин
~альфа-глюкозидаза

}

Вещество, вырабатываемые в придатках яичка: {

~цинк
~фруктоза
~щелочная и кислая фосфатазы
~спермидин и спермин
=альфа-глюкозидаза

}

Монорхизм – это {

=односторонняя гонадная агенезия

- ~гонадная агенезия яичка
- ~односторонний крипторхизм (другое яичко расположено в мошонке)
- ~односторонний вывих яичка
- ~гермафродитизм

}

Анорхизм - это: {

- ~двустороннее неопущение яичек
- ~отсутствие одного яичка в мошонке
- =двухсторонняя гонадная агенезия
- ~гипоплазия яичек
- ~синдром феминизирующих яичек

}

Синорхидизм - это: {

- ~гипоплазия яичек
- ~врожденное отсутствие яичек
- ~отсутствие одного яичка в мошонке
- =сращение яичек
- ~перекрёстная дистопия яичек

}

Самым частым осложнением крипторхизма является: {

- ~водянка яичка
- =атрофия яичка
- ~опухоль яичка
- ~водянка оболочек яичка
- ~перекрут яичка

}

Расположение яичка вне нормального пути его физиологического перемещения {

- ~анорхизм
- ~синорхидизм
- ~крипторхизм
- =эктопия
- ~монорхизм

}

Наиболее частым пороком развития мочеиспускательного канала {

- ~синорхидизм
- ~крипторхизм
- ~эктопия
- =гипоспадия
- ~уретрит

}

Частота аномалий развития яичек мальчиков {

- ~0,1-0,5%
- =1,5-5%
- ~5-8%
- ~8-10%
- ~более 10 %

}

Какова частота самостоятельной ликвидации гидроцеле к концу первого года жизни: {

- ~не проходит, надо оперировать
- ~5-10 %
- =до 30%
- ~около 50%
- ~более 70%

}

Крипторхизм – это: {

=неопущение яичка
~отсутствие яичка
~недоразвитие яичка
~скопление жидкости между оболочки яичка
~атрофия яичка
}

Агенезия яичка – это: {
~неопущение яичка
=отсутствие яичка
~недоразвитие яичка
~скопление жидкости между оболочки яичка
~атрофия яичка
}

Гидроцеле – это: {
~неопущение яичка
~отсутствие яичка
~недоразвитие яичка
=скопление жидкости между оболочки яичка
~атрофия яичка
}

Гипоплазия яичка – это {
~неопущение яичка
~отсутствие яичка
=недоразвитие яичка, уменьшение
~скопление жидкости между оболочки яичка
~атрофия яичка
}

Самый частый вид крипторхизма, как правило, не требующий лечения: {
~паховый
=ложный
~бедренный
~абдоминальный
~все не требуют лечения
}

Заболевание, для которого характерно сужение отверстия крайней плоти, не позволяющее полностью открыть головку полового члена {
~синорхидизм
~крипторхизм
~эктопия
=фимоз
~гипоспадия
}

Самой частой аномалией полового члена является: {
~апостия
~дифаллия
=врожденный фимоз
~агенезия
~уретрит
}

Наиболее частым пороком развития мочеиспускательного канала является: {
~эписпадия
=гипоспадия
~врожденная стриктура уретры
~удвоение уретры
~уретро-прямокишечные свищи

}

Что не относится к выделениям уретры: {

~слизисто-гнойные выделения.

~лейкоцитарные выделения

=галакторея

~сперматорея.

~гематорея

}

Разница между специфическим и неспецифическим уретритами: {

~разный подход к диагностике

=необходимости лечить всех партнеров пациента

~принципиально разные симптомы заболеваний

~нет разницы в диагностике и лечении

~лечение специфического уретрита проводится строго в стационаре

}

Осложнения острого уретрита не относятся: {

~переход в хроническую форму;

~простатит;

~везикулит;

=нефрит;

~орхит

}

Сужение или полное заращение просвета мочеиспускательного канала: {

~специфический уретрит

~неспецифический уретрит

=стриктура уретры

~дивертикул уретры

~гипоспадия

}

Размеры короткой стриктуры уретры по протяженности составляют: {

~до 1 см

=до 2 см

~до 3 см

~до 5 см

~менее половины длины всей уретры

}

Простейший одноклеточный паразит, крайне чувствительный ко многим факторам окружающей среды: {

~N. gonorrhoeae

~C. trachomatis

=T. vaginalis

~Mycoplasma genitalium

~U. urealyticum

}

Симптомы острого трихомонадного уретрита: {

~воспалительный процесс протекает с гнойными выделениями из уретры, дизурией;

~субъективные симптомы незначительны, выделения из уретры скудные, белого или серовато-желтого цвета;

=малосимптомный, скудость симптомов, нередко их полное отсутствие;

~кровянистые выделения из уретры с характерным резким запахом;

~характеризуется высыпаниями в области гениталий

}

Осложнения хламидиоза у мужчин, кроме: {

~бесплодие;

~невынашивание беременности и пороки развития плода;

~эпидидимит;
=пиелонефрит
~синдром Рейтера

}

Симптомы уреаплазмоза у мужчин, кроме: {
~появление прозрачных выделений из уретры;
~нарушение мочеиспускания;
=задержка мочи;
~появление умеренной боли и жжения в процессе мочеиспускания
~влияние на наступление и течение беременности

}

Заболевание с симптомами развивается при наличии предрасполагающих факторов, что вызывается достижением или превышением порогового уровня концентрации микроорганизмов: {

~хламидиоз
~гонорея
~трихомониаз
=уреаплазмоз
~муковисцидоз

}

Возбудитель хламидийного уретрита: {

~хламидия хоминис
~хламидия уреалитикум
=хламидия трахоматис
~хламидия ауреус
~все перечисленные

}

Инкубационный период при трихомонадной инвазии составляет в среднем: {

~1 – 2 дня
~менее 1 дня
=5 – 15 дней
~1 – 2 месяца
~от 2 месяцев до полугода

}

Симптомы трихомониаза, кроме: {

~слизистые, слизисто-мутные выделения из уретры;
~зуд, жжение в области уретры;
~боли в промежности с иррадиацией в прямую кишку;
=задержка мочи;
~дизурия

}

Инкубационный период при заражении гонореей в среднем: {

~1-2 дня
~менее 1 дня
=3-7 дней
~2-4 недели.
~от 1 месяца

}

Пути передачи герпеса: {

~половой;
~контактно-бытовой;
~воздушно-капельный;
~от матери ребенку во время беременности и родов;
=все перечисленные

}

Для лабораторной диагностики цитомегаловируса используется: {

- ~анализ биологических жидкостей;
 - ~ПЦР;
 - ~культуральное исследование (посев);
 - ~анализ крови на антитела.
- =все перечисленные

}

Пути передачи ВПЧ, кроме: {

- ~половой;
 - ~во время родов (при прохождении по родовым путям);
 - ~контактно-бытовой путь.
- =воздушно-капельный.
- ~все перечисленные пути передают ВПЧ

}

Сколько штаммов ВПЧ известно на сегодняшний день: {

- ~3 вида
 - ~25 видов
 - ~20 видов
 - ~50 видов
- =более 100 видов

}

В большинстве случаев (до 80-90%) организм справляется с инфекцией самостоятельно, подавляя вирус в течение 1-2 лет: {

- ~цитомегаловирус
 - ~генитальный герпес
- =вирус папилломы человека
- ~вирус герпеса
 - ~вирус гепатита С

}

Им инфицировано большая часть населения планеты, вирус находится в организме в скрытой форме, не составляя проблем для здоровья: {

- ~вирус иммунодефицита человека
- =цитомегаловирус
- ~Covid-19
 - ~вирус гепатита В
 - ~вирус гепатита С

}

Инкубационный период: {

- =промежуток времени от момента заражения до появления клинических симптомов болезни
- ~период, за который развиваются осложнения
 - ~период, возможного самоизлечения организма
 - ~все верно
 - ~период жизни микроорганизмов

}

Какие андрологические нарушения не возникают при варикоцеле: {

- ~боль и дискомфорт в мошонке
 - ~бесплодие
 - ~нарушение роста и развития ипсилатерального яичка
- =эректильная дисфункция
- ~уменьшения яичка

}

Расширение вен семенного канатика: {

- ~гидроцеле
- ~сперматоцеле

- =варикоцеле
- ~фуникулоцеле
- ~пиоцеле

}

Скопление серозной жидкости между собственными оболочками яичка. {

- =гидроцеле
- ~сперматоцеле
- ~варикоцеле
- ~фуникулоцеле
- ~пиоцеле

}

Киста придатка яичка: {

- ~гидроцеле
- =сперматоцеле
- ~варикоцеле
- ~фуникулоцеле
- ~пиоцеле

}

Киста семенного канатика: {

- ~гидроцеле
- ~сперматоцеле
- ~варикоцеле
- =фуникулоцеле
- ~пиоцеле

}

Частые ночные мочеиспускания: {

- ~энурез
- =никтурия
- ~диурез
- ~ноктурия
- ~странгурия

}

Фуникулоцеле: {

- =киста семенного канатика
- ~киста придатка яичка
- ~киста яичка
- ~воспаление яичка и придатка
- ~ничего из перечисленного

}

Основные этиологические факторы эпидидимита: {

- =инфекции урогенитальной сферы
- ~инфекции верхних мочевыводящих путей
- ~оперативные вмешательства на почке
- ~врожденные причины
- ~все перечисленные факторы

}

Самый распространенный тип орхита: {

- =паротитный орхит
- ~хламидийный орхит
- ~уреаплазменный орхит
- ~гонорейный орхит
- ~туберкулёзный орхит

}

Что первично поражается при эпидидимите: {

- ~ткань яичка

~белочная оболочка яичка

=хвост придатка

~тело придатка

~головка придатка

}

С каким заболеванием проводят дифференциальный диагноз при эпидидимите {

~варикоцеле

~гидроцеле

~гематоцеле

=перекрут семенного канатика

~перекрут гидатиды

}

К осложнениям операций по методикам Иванисевича и Паломо относятся все, кроме:

{

~формирование гидроцеле

=эректильная дисфункция

~травма яичковой артерии

~атрофия яичка

~рецидив варикоцеле

}

При правостороннем варикоцеле необходимо исключить: {

~сужении правой почечной вены

=опухоли забрюшинного пространства

~нефроптозе

~ожирении

~опухоли печени

}

Какая локализация варикоцеле проявляется чаще? {

~двусторонняя

~правосторонняя

=левосторонняя

~одинаково с обеих сторон

~нет таких связей

}

Третья стадия варикоцеле характеризуется: {

~положительная проба Вальсальвы

~боль в яичке при нагрузке

~гипоплазия яичка

~бесплодие

=все верно

}

Оперативные методы лечения варикоцеле, кроме: {

=операция Бергмана

~операция Иванисевича

~операция Мармара

~эндоскопические методы

~рентгеноваскулярные метод

}

Диагностическая проба для варикоцеле: {

~Курцрока-Миллера

~Реберга

=Вальсальвы

~Нечипоренко

~Хэда

}

Осложнениями после варикоцелэктомии являются все, кроме: {

~гидроцеле

~нагноение послеоперационной раны

~кровотечение

=гематурия

~рецидив

}

Для постановки диагноза острый эпидидимоорхит не используется: {

~осмотр,

~сбор анамнеза,

~пальпация органов мошонки

~УЗИ органов мошонки

=КТ органов мошонки

}

В классификацию, предложенную Американского Национального Института Здравоохранения (NIH USA) в 1995 году, не входит: {

~острый простатит

~хронический бактериальный простатит

=калькулезный простатит

~синдром хронической тазовой боли

~асимптоматический простатит

}

Согласно классификации, предложенная Американского Национального Института Здравоохранения (NIH USA) в 1995 году, Категория I, это: {

~хронический простатит /синдром хронической тазовой боли с признаками воспаления

~хронический простатит / синдром хронической тазовой боли без признаков воспаления;

=острый простатит

~хронический бактериальный простатит

~асимптоматический хронический простатит

}

Согласно классификации, предложенная Американского Национального Института Здравоохранения (NIH USA) в 1995 году, Категория II, это: {

~хронический простатит / синдром хронической тазовой боли с признаками воспаления

~хронический простатит / синдром хронической тазовой боли без признаков воспаления;

~острый простатит

=хронический бактериальный простатит

~асимптоматический простатит.

}

Согласно классификации, предложенная Американского Национального Института Здравоохранения (NIH USA) в 1995 году, Категория IIIa, это: {

=хронический простатит / синдром хронической тазовой боли с признаками воспаления

~хронический простатит / синдром хронической тазовой боли без признаков воспаления;

~острый простатит

~хронический бактериальный простатит

~асимптоматический простатит.

}

Согласно классификации, предложенная Американского Национального Института Здравоохранения (NIH USA) в 1995 году, Категория IIIb, это: {

~хронический простатит / синдром хронической тазовой боли с признаками воспаления

=хронический простатит / синдром хронической тазовой боли без признаков воспаления;

~острый простатит

~хронический бактериальный простатит
~асимптоматический простатит

}

Согласно классификации, предложенная Американского Национального Института
Здравоохранения (NIH USA) в 1995 году, Категория IV, это: {

~хронический простатит / синдром хронической тазовой боли с признаками воспаления
~хронический простатит / синдром хронической тазовой боли без признаков
воспаления;
~острый простатит
~хронический бактериальный простатит
=асимптоматический простатит.

}

Частота рецидивирующей хронического бактериального простатита: {

~5-10%
=20-25%;
~25-50%
~50-60%
~более 60%

}

Частота синдрома хронической тазовой боли (Категория III): {

~менее 10 %
~10-20%
~30%;
~около 50%
=80-90%.

}

Ведущим возбудителем бактериального простатита является: {

=E. Coli
~Chlamydia trachomatis
~Ureaplasma urealyticum
~Mycoplasma hominis
~Ureaplasma parvum

}

Самая частая причина задержки мочеиспускания у мужчин: {

~простатит;
=ДГПЖ;
~киста предстательной железы;
~сахарный диабет;
~бесконтрольный прием медицинских препаратов

}

Самое частое заболевание предстательной железы у мужчин старшего возраста: {

~простатит
=доброкачественная гиперплазия предстательной железы;
~рак предстательной железы;
~киста предстательной железы;
~склероз предстательной железы.

}

Самое частое заболевание предстательной железы у мужчин до 50 лет: {

=простатит
~доброкачественная гиперплазия предстательной железы;
~рак предстательной железы;
~киста предстательной железы;
~склероз предстательной железы

}

Источником роста аденоматозных узлов при ДГПЖ являются {

- ~семенной бугорок
- =парауретральные железы
- ~семявыбрасывающие протоки
- ~капсула предстательной железы
- ~ацинусы предстательной железы

}

Распространенность ДГПЖ у мужчин в возрасте старше 80 лет достигает {

- ~30-40%

- ~50%

- =более 80%

- ~100%

- ~76%

}

Динамическое наблюдение при отсутствии значимых жалоб у мужчин с СНМП не включает {

- ~периодическое обследование

- =психологическую поддержку

- ~рекомендации относительно образа жизни

- ~коррекция сопутствующих заболеваний

- ~рекомендовано все перечисленное

}

Нормальный объем предстательной железы {

- ~до 15 см³

- =до 25-30 см³

- ~от 30 до 40 см³

- ~от 40 до 80 см³

- ~более 80 см³

}

К малоинвазивным методам лечения ДГПЖ не относятся: {

- ~трансуретральная микроволновая терапия

- =трансуретральная резекция

- ~интерстициальная лазерная коагуляция.

- ~простатические стенты

- ~баллонная дилатация

}

Не является абсолютным показанием к операции: {

- ~острая задержка мочи

- ~хроническая задержка мочи

- =рецидивная инфекция мочевых путей

- ~камни мочевого пузыря

- ~почечная недостаточность вследствие ДГПЖ

}

// Занятие 7. Гипогонадизм. Мужское бесплодие. (ПК-1 ИД-4) Гипогонадизм, или тестикулярная недостаточность: {

- =состояние, обусловленное снижением в организме уровня андрогенов

- ~уменьшение яичек

- ~уменьшение гонадотропных гормонов

- ~уменьшение количества сперматозоидов

- ~все перечисленное

}

Синонимы возрастного гипогонадизма все, кроме: {

- ~мужской климакс

- =гипофизарный нанизм

- ~возрастной андрогенодефицит

- ~андропауза

~все перечисленные являются синонимами

}

Как называется возрастной гипогонадизм без клинических проявлений: {

=физиологический;

~патологический;

~идиопатический;

~смешанный;

~транзиторный

}

Ранний возрастной гипогонадизм развивается в возрасте {

~до 25 лет

~до 30 лет;

=до 45 лет;

~от 46-60 лет;

~после 60 лет.

}

К проявления возрастного снижения уровня андрогенов не относятся: {

~мочеполовые расстройства:

~вегетососудистые расстройства:

=вербальные расстройства

~психоэмоциональные расстройства:

~соматические расстройства

}

Где происходит разрушение тестостерона: {

~в почках;

~в мышцах;

=в печени;

~в поджелудочной железе;

~в селезенке

}

С возрастом у мужчин уровень тестостерона: {

~остается постоянным

=снижается 1-2% в год

~снижается на 5-10% в год

~снижается на 1-2% в месяц

~незначительно повышается

}

Перед назначением заместительной гормональной терапии у мужчин необходимо: {

~установить уровень андрогенов

~определить уровень ПСА

~провести пальцевое ректальное исследование

~нет противопоказаний

=все перечисленное верно

}

Брак следует считать бесплодным, если беременность не наступает: {

~в течение 6 мес.

=в течение 1 года

~в течение 2 лет

~в течение 3 лет

~течение 3 месяцев

}

Бесплодие, связанное с нарушением процесса образования мужских половых клеток и спермы: {

=секреторное бесплодие

~экскреторное бесплодие

- ~иммунологическое бесплодие
- ~сочетанное бесплодие
- ~идиопатическое бесплодие

}

Бесплодие, связанное с нарушением транспорта сперматозоидов: {

- ~секреторное бесплодие
- =эскреторное бесплодие
- ~иммунологическое бесплодие
- ~сочетанное бесплодие
- ~идиопатическое бесплодие

}

Бесплодие, связанное с выработкой в организме антиспермальных антител: {

- ~секреторное бесплодие
- ~эскреторное бесплодие
- =иммунологическое бесплодие
- ~сочетанное бесплодие
- ~идиопатическое бесплодие

}

Какого бесплодия по локализации причин у мужчин не бывает {

- ~секреторного
- ~эскреторного
- =инкреторного
- ~идиопатического
- ~смешанного

}

Что не относится к прогностическим факторам при бесплодии: {

- ~длительность бесплодия
- ~первичное или вторичное бесплодие
- =вредные привычки
- ~состояние спермограммы
- ~возраст и статус плодовитости

}

Механизмы нарушения сперматогенеза при варикоцеле: {

- ~повышение температуры органов мошонки.
- ~нарушение кровотока сопровождается нарушением «питания» и обмена веществ в яичке.
- ~иммунологическое бесплодие
- ~нарушение гормональной функции яичка.
- =все перечисленное

}

Причины формирования антиспермальных антител: {

- ~инфекции половой системы
- ~травмы и операции
- ~варикоцеле,
- ~анатомические нарушения (паховая грыжа, нарушение)
- =все перечисленное верно

}

Криптозооспермия – это: {

- ~менее 5 млн. сперматозоидов
- ~наличие большого количества незрелых форм сперматозоидов в эякуляте
- =наличие единичных сперматозоидов, определенных после центрифугирования эякулята
- ~отсутствие сперматозоидов в эякуляте после центрифугирования.
- ~все сперматозоиды неподвижны

}

Тератозооспермия – это: {

~<32% подвижных сперматозоидов;

=<4% сперматозоидов нормальной формы

~<15 млн сперматозоидов в 1 мл

~количество клеток сперматогенеза больше 4%

~нормальная спермограмма

}

Полизооспермия – это содержание сперматозоидов в 1 мл эякулята свыше {

~50 млн

~100 млн

=200 млн

~300 млн

~400 млн

}

Нижней границей нормы количества сперматозоидов в 1 мл является (по критерию ВОЗ 2010) {

=15 млн

~40 млн

~60 млн

~80 млн

~100 млн

}

Доля присутствия мужского фактора бесплодия в браке: {

~10%

~30%

=50%

~70%

~более 70%

}

Частота идиопатического бесплодия: {

~до 5%

~5-10%

~10-20%

~20-30%

=30-50%

}

При обнаружении делеции на каком участке AZF прогноз для получения сперматозоидов худший: {

=AZFa

~AZFb

~AZFc

~только если есть сочетания делеций локусов

~не имеет значения

}

При обнаружении делеции на каком участке AZF прогноз для получения сперматозоидов самый лучший: {

~AZFa

~AZFb

=AZFc

~только в сочетании делеций локусов

~не имеет значения

}

Решающее значение для диагностики фертильности у мужчин является: {

=значение спермограммы

~состояние супруги

- ~посев секрета простаты
- ~биопсия предстательной железы
- ~исследование содержимого семенных пузырьков

} При оперативном лечении обструктивной азооспермии выполняют: {

- =вазовазоанастомоз
- ~вазоилеоанастомоз
- ~вазорезекцию
- ~реверсивную вазэктомию
- ~трансплантацию яичка

}

Какие 2 специальности вносят наибольший вклад в андрологию: {

- ~сексология
- =урология
- ~онкология
- =эндокринология
- ~дерматовенерология

}

Укажите основные направления, являющиеся составными частями андрологии: {

- =гипогонадизм;
- =мужское бесплодие;
- =детская андрология;
- ~заболевания щитовидной железы;
- =сексуальные дисфункции;

}

Задачи детской андрологии: {

- =наблюдение за развитием органов репродуктивной системы начиная с рождения и до достижения 18 лет;
- ~диспансеризация школьников и детей в детских садах;
- =углубленная диагностика заболеваний органов репродуктивной системы, с целью определения репродуктивного прогноза;
- =решает вопросы как терапевтического, так и хирургического лечения ребенка с заболеваниями органов репродуктивной системы;
- ~лечение бесплодия в браке

}

К внутренним половым органам относятся: {

- =яички и их придатки,
- ~мошонка
- =семявыносящие и семявыбрасывающие протоки,
- =бульбоуретральные железы,
- =простата и семенные пузырьки.

}

Передний отдел включает в себя: {

- ~бульбозный отдел,
- ~ладьевидную ямку,
- ~шейка мочевого пузыря,
- ~пенильный отдел
- ~мембранозный отдел

}

Тестостерон влияет на {

- =костную и мышечную массу,
- ~зрение,
- =эритропоэз,
- =регулирует сперматогенез,
- =половое влечение и потенцию

}

Функции яичек: {

~выработка семенной плазмы

~лимфогенная

=сперматогенез

~симпатическая

=выработка тестостерона

}

Передний отдел включает в себя: {

=бульбозный отдел

=пенильный отделы

~кавернозной отдел

~мошоночный отдел

=ладьевидная ямка.

}

Задняя уретра представлена: {

~шейкой мочевого пузыря,

=простатический отдел

~мошоночный отдел

~бульбозный отдел

=мембранозной отделами

}

Какие отделы не входят в заднюю уретру: {

=бульбозный отдел,

~шейка мочевого пузыря,

~простатический отдел

~мембранозной отдел

=пенильный отдел

}

Что входит в состав эякулята: {

=семенная плазма

~тельца Руффини

=форменные элементы

~тельца Жолли

~кольца Кебота

}

В состав семенного канатика входят: {

=семявыносящий проток

=артерии

~семенной бугорок

=венозное лозовидное сплетение

=нервы

}

Общие симптомы для всех форм простатита {

~повышение температуры;

=расстройства мочеиспускания;

=боли;

=влияние на качество жизни;

~астения

}

Какие функции выполняет предстательная железа: {

~антиоксидантную

=моторную

=секреторную

=барьерную

~иммунную

}

Что входит в строение сперматозоида: {

=головка

=шейка

~брюшко

~луковица

=хвост

}

Кровоснабжение яичка осуществляется: {

~лучевая артерия

=яичковой артерией

=кремастерной артерией

=артерией семявыносящего протока

~бедренная артерия

}

Гормональная регуляция мужской репродуктивной системы осуществляется

гормонами гипофиза: {

=лютеинизирующий гормон

=фолликулостимулирующий гормон

~глюкагон

=пролактин

~инсулин

}

Повышение ПСА может быть связано: {

=раком простаты;

=простатитом;

=доброкачественной гиперплазией (аденомой) простаты;

~наличием внутриутробных инфекций;

=механическим воздействием на простату (массаж простаты, биопсия простаты и т.д.)

}

Главный «регуляторы» мужской репродуктивной системы мужчины: {

=гипофиз

=гипоталамус

~надпочечники

=тестикулы

~печень

}

// Занятие 2. Методы обследования андрологических пациентов. (ПК-1 ИД-4)

Специальный осмотр андрологического пациента включает в себя: {

=характер оволосенения лобка,

~пальпация органов брюшной полости,

=состояние органов мошонки,

~измерение АД и пульса,

=ректальное исследование предстательной железы.

}

Методы исследования на ЗППП: {

=ИФА анализ крови

~спермограмма

=культуральный метод

=ПЦР

~кариотипирование

}

Укажите 2 наиболее эффективных метода диагностики ЗППП: {

~мазок на флору

=ПЦР

~ИФА

=культуральный метод

~бакпосев

}

Что не входит в подготовку перед проведением исследований на ЗППП: {

~3-4 часа и более не мочиться перед анализом

~ограничение физических нагрузок накануне

=не употреблять пищу не менее 8 часов до забора крови

~не принимать антибиотиков не менее 2 недель

~не курить перед анализом

}

Показания к бактериологическому исследованию на флору: {

=воспалительные процессы мочеполовых путей;

~аномалии развития плода

=контроль результатов антибактериального лечения:

~бесплодие;

~невынашивание беременности

}

Что не входит в показания для гормонального обследования андрологического пациента: {

~бесплодие;

~первичный и вторичный гипогонадизм,

=гнойные выделения из уретры

~снижение либидо и эрекции.

~контроль при приеме препаратов тестостерона

}

Основные генетические исследования в андрологической практике включают: {

~иммунохемилюминесцентный анализ;

=кариотипирование;

=исследование делеций Y хромосомы на участке AZF;

=исследование на муковисцидоз;

~иммуноферментный анализ

}

Ультразвуковое исследование позволяет рассмотреть и измерить {

=структуру, размеры органа;

=обнаружить в его составе очаги новообразований, полости и кисты,

~уродинамические характеристики

=обнаружить различные включения (камни, инородные тела и прочее);

=диаметр и скорость кровотока в сосудах.

}

Основные варианты ультразвуковой диагностики предстательной железы: {

~эндоскопический

=трансабдоминальный

~трансперитонеальный

=трансректальный

~эндовазальный

}

Возможные осложнения уретроскопии: {

=инфицирование

=травма уретры;

=кровотечение;

=уменьшение или ослабление оттока мочи.

~бесплодие

}

Виды уретроскопий: {

=передняя

~боковая

=задняя

~латеральная

~позадилонная

}

Виды уретрографий: {

=восходящая

~передняя

~задняя

=нисходящая

~позадилонная

}

Показания к уретрографии: {

=повреждения уретры;

~бесплодие

=подозрения на аномалии развития;

~патологические процессы в уретре,

=нарушения мочеиспускания.

}

Методы биопсии предстательной железы: {

~Пайпель-биопсия

= "Слепая" биопсия или биопсия простаты под пальцевым контролем;

= Мультифокальная биопсия простаты под УЗИ-контролем;

= Сатурационная биопсия простаты

~Эндоскопическая биопсия простаты

}

Показаниями к уретроскопии являются: {

= хронические воспалительные заболевания уретры

~ невынашивание беременности

= опухоли уретры

= колликулит

~ бесплодие

}

Массаж предстательной железы противопоказан при: {

= остром простатите

= камнях предстательной железы

= тромбозе геморроидальных узлов

~ хроническом простатите

~ синдроме тазовой боли

}

Показания к биопсии яичка: {

= азооспермия – с диагностической целью;

= забор и консервация сперматозоидов при азооспермии или анэякуляции для проведения вспомогательных репродуктивных технологий;

= подозрение на онкологические заболевания яичка;

= подозрение на туберкулез, паразитарные заболевания яичка.

~ снижения количества морфологически нормальных сперматозоидов

}

Виды биопсий яичка: {

~передняя

=открытая

~задняя

=закрытая

~экстренная

}

Осложнения биопсии яичка: {

=кровотечение;

=гематомы мошонки или интратестикулярные гематомы;

=инфицирование операционной раны;

=боли и отек;

~малигнизация

}

// Занятие 3. Спермиологические исследования. (ПК-1 ИД-4) Исследования эякулята

включает себя: {

=базовые тесты

~регрессионные тесты

~интеграционные тесты

=расширенные тесты

~исследовательские тесты

}

Макроскопические параметры эякулята: {

=объем эякулята

=цвет эякулята

=вязкость

=разжижение

~агглютинация

}

Микроскопические параметры эякулята: {

=количества сперматозоидов;

=подвижности сперматозоидов;

=морфологии сперматозоидов;

~разжижение;

=агглютинация и агрегация сперматозоидов

}

Укажите параметры спермограммы, связанные с оценкой количества сперматозоидов:

{

=азооспермия

=криптозооспермия

~тератозооспермия

=олигозооспермия

~астенозооспермия

}

Подвижность расценивается в 3 категориях (до 2010 года в 4 категориях): {

~активные

=прогрессивно-подвижные

=непрогрессивно-подвижные

~мертвые

=неподвижные

}

Факторы риска для появления антител в эякуляте: {

=варикоцеле

=оперативные вмешательства

~острый простатит

=крипторхизм

~онкологические заболевания

}

Антитела в эякуляте нередко являются причиной мужского бесплодия, поскольку: {

=закрепляются на мембране сперматозоидов, снижая тем их активность;

- =препятствуют проникновению сперматозоидов в цервикальную слизь;
- =ухудшают жизнеспособность сперматозоидов, способствуют их склеиванию;
- =нарушают процесс оплодотворения сперматозоидами яйцеклетки.

~вызывают воспалительный процесс в предстательной железе и семенных пузырьках

Показаниями к исследованию на фрагментацию ДНК сперматозоидов: {

- =идиопатическое бесплодие (причина неизвестна);
- =после многократных отрицательных попыток искусственного оплодотворения;
- =пациентам с неоднократно происходившими выкидышами;
- =для мужчин старше 45 лет;
- ~гипогонадизм.

Когда MAR-тест не выполняется, кроме: {

- ~при варикоцеле
- ~при некрозооспермии
- ~при очень малом количестве подвижных сперматозоидов
- ~при азооспермии
- =при нормальной спермограмме.

Показания к MAR тесту: {

- ~прием антибиотиков
- =агглютинация сперматозоидов;
- =подготовка к искусственной инсеминации, ЭКО, ИКСИ.
- ~переохлаждение
- ~неблагоприятный исход беременности

Кроме большого спектра андрологических заболеваний, нарушение параметров спермограммы может быть вследствие: {

- =неправильной транспортировки;
- =нарушение сроков воздержания;
- ~времени суток для сдачи анализа
- =нарушение температуры при доставке материала;
- =попадании химических веществ в сперму (мыло, слюна)

Морфология сперматозоидов — параметр, который описывает: {

- =их внешнее строение:
- =размер,
- ~двигательную активность
- =форму,
- =соотношение частей сперматозоида

Олигоастенозооспермия это: {

- =снижение количества сперматозоидов
- ~снижение количества нормальных форм сперматозоидов
- =снижение подвижности сперматозоидов
- ~воспалительный процесс в эякуляте
- ~снижение объема эякулята

Олигоастенотератозооспермия это: {

- =снижение количества сперматозоидов
- =снижение подвижности сперматозоидов
- =снижение количества нормальных форм сперматозоидов
- ~воспалительный процесс в эякуляте
- ~снижение объема эякулята

Астенотератозооспермия это: {

- ~снижение количества сперматозоидов
- =снижение количества нормальных форм сперматозоидов
- =снижение подвижности сперматозоидов
- ~воспалительный процесс в эякуляте
- ~снижение объема эякулята

}

Все пороки развития внутренних органов можно подразделить на 4 группы. {

- =аномалии количества,
- =аномалии положения,
- =аномалии формы и размера,
- =аномалии строения (структуры),
- ~функциональные аномалии.

}

К аномалиям яичек относятся: {

- =агенезия
- ~гипоспадия
- ~эписпадия
- =крипторхизм
- =эктопия

}

К аномалиям уретры относятся: {

- ~агенезия
- =гипоспадия
- =эписпадия
- ~крипторхизм
- ~эктопия

}

Разделяют формы гипоспадий в зависимости от локализации: {

- =передняя
- =средняя
- =задняя
- ~наружная
- ~внутренняя

}

В зависимости от того, на каком уровне имеет место расщепление передней стенки уретры, различают следующие виды эписпадии, кроме: {

- =заднюю,
- ~головки,
- ~стволовую,
- ~тотальную.
- ~переднюю

}

При крипторхизме, одно или оба яичка во внутриутробном периоде не опускаются в мошонку, а может задерживаться: {

- ~на месте нижнего сегмента первичной почки;
- ~в ректальной области;
- =брюшной полости;
- =паховом канале;
- ~плевральной области.

}

Две наиболее частые и легкие формы гипоспадий: {

- =венечная;
- =головчатая;
- ~стволовая;

~мошоночная;
~промежностная.

}

Две наиболее тяжелые формы гипоспадий: {

~венечная;
~головчатая;
~стволовая;
=мошоночная;
=промежностная.

}

В зависимости от того, на каком уровне имеет место расщепление передней стенки уретры, различают следующие виды эписпадии: {

=головки,
=стволовую,
=тотальную,
~латеральную,
~медиальную

}

К условно-патогенным микроорганизмам относятся: {

~N. gonorrhoeae
~C. trachomatis
=M. hominis
~M. genitalium
=U. parvum

}

К абсолютно патогенным микроорганизмам относятся: {

~U. parvum
~M. hominis
=N. gonorrhoeae
=C. trachomatis
=M. genitalium

}

Возбудителями уретрита являются: {

=N. gonorrhoeae
=C. trachomatis
~Neisseria meningitidis
=Mycoplasma genitalium
=U. Urealyticum

}

К ИППП, вызываемым бактериальными инфекциям, относятся: {

=хламидиоз
~трихомониаз
~генитальный герпес
~цитомегаловирус
=гонорея

}

К неинфекционным уретритам относятся: {

=аллергической,
~хламидийный,
=травматической,
~гонококковый,
=лучевой

}

К инфекционным неспецифическим уретритам относятся, вследствие обсеменения: {

=кишечной палочкой,

=стрептококков,
~гонококки,
=стафилококков,
=протей

}

К инфекционным специфическим уретритам относятся: {

=хламидии,
~кишечная палочка,
=гонококки,
=трихомонады,
~протей.

}

К уретральным симптомам относят: {

=выделения из уретры,
=изменения наружного отверстия уретры,
=дизурия,
~острая задержка мочеиспускания
=уретральная боль и зуд.

}

Укажите симптомы уретрита относятся: {

~бесплодие
~преждевременная эякуляция
=частое мочеиспускание
~затрудненное мочеиспускание
=боли при мочеиспускании

}

Возможные осложнения острого уретрита: {

=переход в хроническую форму;
=простатит;
=орхит – воспаление яичка;
=стриктура уретры;
~гипоспадия уретры.

}

Для диагностики стриктуры уретры применяются основные методы: {

~ультразвуковая диагностика
=уретрография.
=уретроскопия.
=урофлоуметрия.
~микроскопия отделяемого уретры

}

К лабораторным методам диагностики уретрита относятся: {

~морфология по Крюгеру
=микроскопия мазка уретры;
~КУДИ
=ПЦР диагностика половых инфекций;
=бактериологическое исследование – посев

}

Причинами появления и развития стриктуры уретры являются: {

=травматические
=ятрогенные
~простатит
=осложнения острого гонококкового уретрита
~длительный постельный режим больного

}

Симптомы стриктуры уретры: {

- =ослабление струи мочи;
- ~озноб, лихорадка;
- =ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;
- =затрудненное мочеиспускание в начале;
- =разбрызгивание струи мочи;
- =уменьшение объема выпускаемой мочи за каждое мочеиспускание

}

По степени сужения стриктуры делятся: {

- =лёгкая;
- =умеренная;
- =тяжёлая;
- =облитерация;
- ~ятрогенная

}

Возбудители уреаплазмоза у мужчин: {

- =Ureaplasma urealyticum
- ~Ureaplasma parvum
- ~Ureaplasma trachomatis
- ~Ureaplasma genitalium
- ~Ureaplasma vaginalis

}

Возбудителями микоплазмоза у мужчин: {

- =Mycoplasma genitalium
- ~Mycoplasma parvum
- =Mycoplasma hominis
- ~Mycoplasma urealyticum
- ~Mycoplasma vaginalis

}

Симптомы уреаплазмоза у мужчин: {

- =появление прозрачных выделений из уретры;
- ~нарушение мочеиспускания;
- ~воспаления яичка (орхит);
- ~астения, апатия;
- =появление умеренной боли и жжения в процессе мочеиспускания.

}

Какие осложнения, влияющие на репродуктивную систему мужчин, могут оказывать ИППП: {

- =эректильную дисфункцию
- =бесплодие
- ~невынашивание беременности
- ~аномалии развития плода
- =снижение либидо

}

Проявления ИППП зависят от: {

- ~вида возбудителя
- =активности возбудителя
- =инкубационного периода возбудителя
- ~пути заражения;
- ~от течения болезни у заразившей партнёрши

}

Основные пути передачи ИППП: {

- =половой;
- ~контактно-бытовой;
- ~воздушно-капельный;
- =от матери ребенку во время беременности и родов,

~гематогенный/лимфогенный.

}

Возможные пути проникновения хламидийной инфекции в организм человека: {

=заражение при половых контактах;

~трансплацентарная передача плоду от больной матери;

=поражение ребенка при прохождении по родовым путям больной матери;

~воздушно-капельный;

=редко контактно-бытовой

}

Симптомы хламидиоза {

=необильные слизистые или слизисто-гнойные выделения из уретры;

~повышенная раздражительность

=зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании;

=дискомфорт, зуд, жжение в области уретры;

~повышение температуры тела

}

Осложнения хламидиоза: {

=бесплодие;

=эпидидимит;

~эректильная дисфункция;

=синдром Рейтера;

=стриктуры

}

Методы диагностики острого трихомонадного уретрита: {

~ИФА крови;

=микроскопический метод – исследуют как окрашенный, так и неокрашенный, нативный препараты;

=ПЦР диагностика;

=посев на трихомонаду;

~МАР-тест.

}

Основные способы передачи цитомегаловируса: {

=воздушно-капельный путь;

~контактно-бытовой;

=половой путь (содержится в сперме и цервикальном секрете);

=вертикальный – от беременной матери к ребенку или с грудным молоком; при кормлении;

=трансмиссивным путем – при переливании крови, содержащей возбудителей

}

Причины варикоцеле: {

=врожденное нарушение или полное отсутствие клапанов вены около яичек;

~застойный простатит;

~прием медицинских препаратов;

=конституции мужчин со степенью риска – слабость венозных стенок гроздевидного сплетения;

~бесплодие

}

Диагностика варикоцеле включает в себя: {

=осмотр и пальпация органов мошонки;

~УЗИ предстательной железы;

=доплерография вен семенного канатика;

~КТ органов мошонки;

~оценка уровня ТТГ

}

Осложнения варикоцеле: {

- =мужское бесплодие;
- ~эректильная дисфункция;
- =дискомфорт, боль в мошонке;
- =гипотрофия яичка;
- ~воспаление придатка и яичка

}

Какие утверждения, связанные с варикоцеле являются верными: {

- =чаще встречается слева;
- ~чаще встречается справа;
- ~частота с обеих сторон одинаковая;
- =является фактором бесплодия до 30-40% случаев;
- ~чаще болеют работники физического труда и лица, интенсивно занимающиеся спортом

}

Нарушения сперматогенеза при варикоцеле возникают вследствие {

- =местного повышения температуры
- =гипоксии
- ~местного понижения температуры
- ~нарушения гипоталамо-гипофизарной оси
- ~пузырно-мочеточникового рефлюкса

}

Классификация варикоцеле, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) включает следующие степени: {

- ~субклиническое варикоцеле
- =1 степень;
- =2 степень;
- =3 степень;
- ~4 степень

}

Каковы показания к хирургическому лечению варикоцеле? {

- =бесплодие в браке
- ~повторяющиеся воспаления органов малого таза;
- =наличие болевого синдрома или психологический дискомфорт
- =гипоплазия яичка
- ~эректильная дисфункция

}

По характеру венозного рефлюкса варикоцеле определяют: {

- =со смешанным вариантом рефлюкса
- =с ренотестикулярным рефлюксом
- =с илеотестикулярным рефлюксом
- ~с пузырно-мочеточниковым рефлюксом
- ~с гастроэзофагальным рефлюксом

}

Причины кисты придатка яичка: {

- =воспалительный процесс в придатке яичка;
- ~злоупотребление курением и алкоголем;
- =травма придатка яичка;
- ~бесплодие;
- ~поликистоз почек.

}

Диагностика кисты сперматоцеле выставляется на основании: {

- ~исследования секрета простаты;
- =на основании осмотра и пальпации придатков яичка;
- =УЗИ органов мошонки;
- ~спермограммы;

~ТРУЗИ простаты

}

Общие симптомы для воспалений придатка и яичка: {

=отек и покраснение мошонки на стороне поражения мошонки

=ощущение дискомфорта и боли в яичках;

~эректильная дисфункция;

=лихорадка, озноб;

~образования на яичке

}

Диагностика эпидидимоорхита основывается на данных: {

~анамнеза;

~осмотра и пальпации органов мошонки;

~гормонального обследования;

~УЗИ органов мошонки;

~ТРУЗИ

}

Что верно в отношении принципов лечения больных гнойным эпидидимоорхитом: {

=постельный режим.

=необходима иммобилизация органов мошонки.

~обязательное лечение партнерши

=максимально быстрое назначение комплексного лечения с учетом клинической формы заболевания.

=возможно оперативное лечение

}

Причины гидроцеле: {

~застойный простатит;

=при травме яичка;

=оперативные вмешательства на половых органах;

=при новообразовании органов мошонки;

~половые конгестии

}

Диагностика гидроцеле осуществляется на основании: {

=осмотра

=диафаноскопии

=УЗИ органов мошонки

~Уретрографии

~Уретроскопии

}

Осложнения гидроцеле: {

=дискомфорт и боли в области мошонки, чаще при движении;

=нарушение кровоснабжения яичка и сперматогенеза;

=присоединение воспалительного процесса, вплоть до нагноения;

=косметические неудобства.

~эректильная дисфункция

}

Укажите заболевания яичка: {

~варикоцеле

~гидроцеле

=орхит

~эпидидимит

~фуникулоселе

}

К общим признакам и симптомам острого простатита относится все, кроме: {

~озноб

~дизурия

- =параплегия
- ~повышение температуры тела
- ~бесцветные или беловатые гнойные выделения из уретры

} Общие симптомы для всех форм простатита {

- =расстройства мочеиспускания;
- =боли;
- ~повышение температуры тела;
- =влияние на качество жизни;
- ~задержка стула

}

Предрасполагающие факторы развития простатита: {

- =длительные периоды воздержания, нерегулярность половой жизни;
- ~физические нагрузки, занятие спортом;
- ~наследственность;
- =малоподвижный образ жизни;
- =сопутствующие заболевания мочеполовой системы (уретрит, цистит, пиелонефрит).

}

Диагностика простатита осуществляется на основании: {

- =жалоб пациента;
- =УЗИ предстательной железы;
- ~рентгенологическое исследование;
- ~колоноскопия;
- =локализационный тест

}

Согласно классификации, предложенная Американского Национального Института Здравоохранения (NIH USA) в 1995 году, синдром хронической тазовой боли соответствует категориям простатита:{

- ~Категория I;
- ~Категория II;
- =Категория IIIa;
- =Категория IIIb;
- ~Категория IV

}

Асимптоматический хронический простатит выявляется при наличии у пациента: {

- ~бесплодия;
- ~нарушенного мочеиспускания;
- =повышение ПСА;
- ~параплегии;
- ~задержка стула.

}

Массаж предстательной железы противопоказан при: {

- ~обследование мужчин старше 45 лет
- ~хроническом простатите
- =остром простатите
- =камнях предстательной железы
- =тромбофлебите геморроидальных узлов

}

По размерам ДГПЖ выделяют:{

- ~очень малая;
- =малая;
- =средняя;
- =крупная;
- ~гигантская

}

При ДГПЖ возможно развитие следующих осложнений {
=острая задержка мочеиспускания
=рецидивирующая инфекция мочевых путей
~бесплодие
=двусторонний уретерогидронефроз и почечная недостаточность
=камни мочевого пузыря
}

К симптомам расстройств мочеиспускания относятся: {
=симптомов фазы накопления
=постмиктурических симптомов
~болевого симптомов
=симптомов фазы опорожнения
~нарушения эякуляции
}

Симптомы фазы накопления: {
~чувство неполного опорожнения мочевого пузыря
=увеличение частоты мочеиспусканий;
=наличие императивных позывов;
=никтурия (ночная поллакиурия);
=ургентное недержание мочи
}

Симптомы фазы опорожнения: {
=вялая струя мочи;
=прерывание струи;
=задержка начала мочеиспускания;
=необходимость натуживания в начале мочеиспускания;
=чувство неполного опорожнения мочевого пузыря
}

К постмиктурическим симптомам у больных ДГПЖ относится {
~ноктурия (ночная полиурия)
=подкапывание после акта мочеиспускания
~разбрызгивание струи
~ургентное недержание мочи
~чувство неполного опорожнения мочевого пузыря
}

Показания к назначению медикаментозной терапии ДГПЖ, кроме {
~высокий операционный риск из-за наличия сердечно-сосудистых заболеваний
=камни мочевого пузыря
~молодой возраст пациентов, желающий сохранить половую функцию
~необходимость отсрочки оперативного лечения для наилучшей подготовки пациентов и профилактики послеоперационных осложнений
=почечная недостаточность вследствие ДГПЖ
}

Противопоказания к назначению медикаментозной терапии ДГПЖ, кроме {
~осложнения ДГПЖ: макрогематурия, камни, дивертикулы мочевого пузыря,
=молодой возраст пациентов
~снижение максимальной скорости мочеиспускания менее 8мл/с
~превышение остаточной мочи > 300 мл
~тяжелая симптоматика ДГПЖ
}

Осложнения ДГПЖ: {
~острая и хроническая задержка мочи;
~бесплодие;
~рак предстательной железы;
=камни мочевого пузыря;

=хроническая почечная недостаточность, гидронефроз

}

// Занятие 7. Гипогонадизм. Мужское бесплодие. (ПК-1 ИД-4) Гипогонадизм разделяют, все кроме: {

~первичный гипогонадизм

~вторичный гипогонадизм

~смешанный гипогонадизм

=сочетанный гипогонадизм

~отсутствие чувствительности к андрогенам органов-мишеней

}

Первичный врожденный гипогонадизм обусловлен причинами: {

~варикоцеле;

=анорхизм;

=синдром Клайнфельтера;

=XX-синдром у мужчин;

~опухоли тестикул.

}

Первичный приобретенный гипогонадизм обусловлен причинами: {

=варикоцеле;

~анорхизм;

~синдром Клайнфельтера;

~XX-синдром у мужчин;

=опухоли тестикул

}

Причины приобретенного гипогонадизма: {

~анорхизм;

~синдром Клайнфельтера;

=инфекционно-воспалительное поражение тестикул;

=опухоли тестикул;

=варикоцеле

}

Синонимы возрастного гипогонадизма: {

=мужской климакс;

=возрастной андрогенодефицит;

~менопауза;

=андропауза;

~старческая аллопеция

}

Диагностика возрастного гипогонадизма включает в себя: {

=опрос;

~спермограмма;

~УЗИ предстательной железы;

=заполнение AMS-опросника или других специальных анкет;

=гормональное обследование

}

К мочеполовым проявлениям возрастного гипогонадизма, относятся: {

=снижение либидо;

~повышение либидо;

=эректильная дисфункция;

=уменьшение яркости оргазма или его отсутствие;

~увеличение грудных желез

}

К вегетососудистым проявлениям возрастного гипогонадизма, относятся: {

~депрессия

=внезапная гиперемия лица, шеи, чувство жара «приливы»;

~нестабильность артериального давления;
=боли в области сердца, не связанные с заболеваниями сердца;
=быстрая утомляемость

}

К психоэмоциональным проявлениям возрастного гипогонадизма, относятся: {

~внезапная гиперемия лица, шеи, чувство жара «приливы»;
=повышенная раздражительность;
~боли в области сердца, не связанные с заболеваниями сердца;
=ослабления памяти и внимания;
=депрессия.

}

К соматическим проявлениям возрастного гипогонадизма, относятся: {

=уменьшение мышечной массы
~депрессия
=снижение минеральной плотности костей
=появление или увеличение количества жировых отложений в области талии и бедер
~бессонница

}

Основные причины, приводящие к мужскому бесплодию: {

=варикоцеле;
~алиментарная аллергия;
=гипогонадизм;
=эндокринная нарушения;
~гиперметропия высокой степени

}

Укажите гормоны гипофиза, участвующие в образовании сперматозоидов: {

~тестостерон;
=лютеинизирующий гормон;
=фолликулостимулирующий гормон;
=пролактин;
~эстрадиол

}

Инфекции мужских половых органов могут быть причиной нарушения репродуктивной функции мужчины, так как: {

=могут привести к воспалению яичек и их придатков;
=могут привести к нарушению проходимости семявыносящих путей;
=могут приводить к изменениям эякулята (снижение количества, подвижности, морфологии сперматозоидов и т.д.);
~могут привести к варикоцеле
~вызывают нарушения эрекции

}

Секреторное бесплодие обусловлено: {

~обтурацией семявыносящих протоков;
=первичная недостаточность яичек;
=вторичная недостаточность яичек;
~воспалительные заболевания мочеполовой системы;
~асперматизм

}

Экскреторная форма бесплодия обусловлена:{

=обтурацией семявыносящих протоков;
~первичная недостаточность яичек;
~вторичная недостаточность яичек;
=воспалительные заболевания мочеполовой системы;
~асперматизм

}

Основные причины повреждения фрагментации ДНК в сперматозоидах: {

=поздний отцовский возраст

~врожденный заболевания

=варикоцеле

=инфекции половых путей.

~молодой возраст

}

При изолированно воспалении семенной плазмы в спермограмме наблюдаются изменения: {

~полиспермия,

=повышенная агглютинация сперматозоидов,

=нарушение вязкости и разжижения,

=пиоспермия,

~азооспермия

}

В зависимости от этого, механизм влияния антиспермальных антител на репродуктивную функцию проявляется следующим образом: {

~лейкоспермия/пиоспермия;

=снижение подвижности сперматозоидов;

=подавление взаимодействия сперматозоида и яйцеклетки;

=нарушение процесса имплантации эмбриона;

~полиспермия

}

Причины формирования антиспермальных антител: {

=инфекции половой системы;

~низкий уровень андрогенов в семенной плазме;

~генетические и врожденные аномалии развития;

=травмы и операции (органов малого таза и мошонки);

=анатомические нарушения (варикоцеле, крипторхизм, перекут яичка и др.)

}

Признаки обструктивного бесплодия: {

=нормальные размеры, тургор (плотность) яичек,

=нормальный уровень половых гормонов,

=отсутствие сперматозоидов в эякуляте и посторгазменной моче;

~повышенный уровень гонадотропинов;

=пальпаторное определение патологии придатков и семявыносящих протоков.

}

Причины гиперэстрогении у мужчин: {

~излишние, усиленные физические нагрузки;

=ожирение;

=метаболический синдром,

=опухоли яичек и надпочечников,

~хронические заболевания предстательной железы

}

Эндокринные расстройства, которые могут приводить к нарушению образования и созревания сперматозоидов: {

=гипогонадизм;

=гиперпролактинемия;

=гиперэстрогения;

=нарушения функции щитовидной железы;

~заболевания вилочковой железы.

}

Бесплодие у мужчин может возникать {

=при врожденных и хромосомных аномалиях развития половых органов

=при тяжелых инфекционно-токсических воздействиях

=при экзогенных и привычных интоксикациях

~при частых рецидивирующих ангинах

~варикоцеле

}

Показаниями к ЭКО являются: {

=патоспермия различной степени выраженности

~аутоиммунный фактор бесплодия

=состояния, обуславливающие невозможность вагинальной эякуляции

=нормоспермия, при женском факторе

~желание супружеской пары

}

Показания к определению AZF фактора, кроме: {

~азооспермия;

~тяжелая олигозооспермия;

~для оценки риска нарушений фертильности у сыновей мужчин, с выявленными делециями AZF;

~идиопатическое бесплодие;

=хронические заболевания органов репродуктивной системы

}

Прогностическим факторам при бесплодии: {

=длительность бесплодия

=первичное или вторичное бесплодие

~вредные привычки

=состояние спермограммы

=возраст и статус плодовитости

}

К вспомогательным репродуктивным технологиям относятся: {

=экстракорпоральное оплодотворение

~гистероскопия шейки матки

=интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида

=внутриматочная инсеминация

~радиоволновая инцизия шейки матки

}